Facteurs associés au faible taux de dépistage du VIH chez les enfants souffrant de malnutrition aiguë reçus au centre hospitalier universitaire Sourô SANOU de Bobo-Dioulasso

Nom du présentateur : Dr TRAORE Isidore T

Auteurs et coauteurs : S E Naon, M A Traore, F N Kabore, A Poda, M Barro/Traore

Affiliations : INSSA§/UNB, Centre MURAZ/INSP, CHUSS

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- En 2023 on estimait à 120 000 [83 000-170 000] le nombre enfants qui ont contracté le VIH
- Cela porte le nombre total d'enfants vivant avec le VIH dans le monde à1,4 millions [1,1 million-1,7 million], dont 86 % en Afrique subsaharienne.
- **Prévalence élevée de l'infection par le VIH chez les enfants malnutris, mais faible taux de dépistage dans ce groupe**

Objectif

Identifier les facteurs associés au faible taux de dépistage du VIH chez les enfants malnutris reçus en pédiatrie au CHUSS de Bobo-Dioulasso

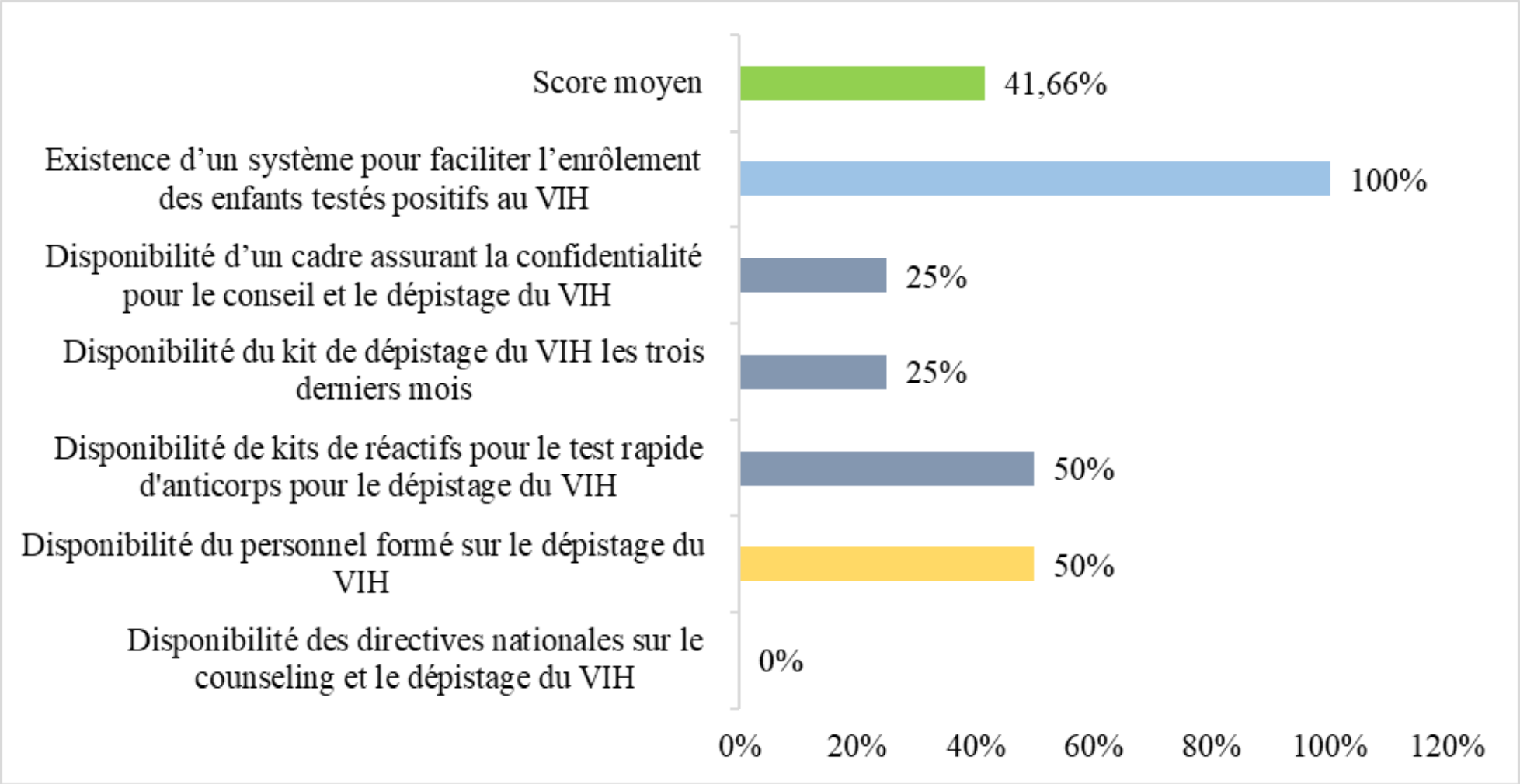
Matériel et méthode(s)

- **Type et période** : transversale du 1er au 14 août 2024
- **Population** d'étude : agents et les responsables des services de la pédiatrie du CHUSS
- **Collecte des données :** questionnaire (mesure de la capacité des services à dépister le VIH, connaissances, attitudes et pratiques des agents).
- **Analyse des données** : régression logistique

Résultats

- Au total **74** agents et **04** responsables de service ont été inclus.
- Sur **98** enfants malnutris admis en pédiatrie au CHUSS dans les trois mois précédant l'enquête, **8,18%** ont bénéficié d'un dépistage du VIH avec zéro cas de séropositivité
- Le score moyen de la capacité opérationnelle des services de la pédiatrie du CHUSS à dépister le VIH chez les enfants malnutris était de **41,02%**

Résultats


Score moyen
41,66%
Existence d'un système pour faciliter l'enrôlement des enfants testés positifs au VIH
100%
Disponibilité d'un cadre assurant la confidentialité pour le conseil et le dépistage du VIH
25%
Disponibilité du kit de dépistage du VIH les trois derniers mois
25%
Disponibilité de kits de réactifs pour le test rapide d'anticorps pour le dépistage du VIH
50%
Disponibilité du personnel formé sur le dépistage du VIH
50%
Disponibilité des directives nationales sur le counseling et le dépistage du VIH
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

Résultats

Tableau 1 : répartition des agents de santé en fonction de leur connaissance sur le conseil et dépistage du VIH

Variables	Effectifs	Proportion (%)
Stratégies de dépistage du VIH chez les enfants en vigueur au Burkina Faso		
PTME/eTME*	66	89,19
Dépistage du VIH en milieu de soins	52	70,27
Dépistage en milieu communautaire	13	**17,57**
« Point of care » (POC)	5	**6,76**
Dépistage familial /Index testing	8	**10,81**
Auto dépistage	4	**5,41**

Résultats

Tableau 2 : répartition des agents de santé en fonction de leur attitude face au conseil et dépistage du VIH

Variables	Effectifs	(%)
Avis sur le CDIP		
Inutile /Sans opinion	**9**	**12,16**
Utile	**65**	**87,84**
Opinion concernant le risque d'infection à VIH chez l'enfant malnutri		
Enfant malnutri à risque	**45**	**60,81**
Enfant malnutri non à risque	**29**	**39,19**

Résultats

La non proposition du test VIH aux enfants malnutris diminuait avec:

- La bonne connaissance des situations pour lesquelles un Conseil et Dépistage est recommandé (OR = 0,06 IC95% : 0,01-0,32),
- La lecture des lignes directrices (OR = 0,15 IC95% :0,02-0,80)
- la rupture des intrants (OR = 0,13 IC95% : 0,02-0, 68)

Conclusion

- Les facteurs du faible taux de dépistage se situent à plusieurs niveaux. Ils freinent dans l'atteinte du premier 95 chez les enfants handicapant ainsi la riposte contre la pandémie de l'infection à VIH.
- D'autres études pourraient se faire dans les structures périphériques afin de déceler d'autres obstacles au dépistage du VIH chez les enfants malnutris.

Merci pour votre attention